

Miedo

Señal de peligro real o percibido

01

FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Protección ante amenazas reales: es una emoción adaptativa y necesaria.
- Activa el sistema de alarma del organismo (amígdala).
- Prepara al cuerpo para responder: luchar, huir o paralizarse.
- El problema no es el miedo — es cuándo aparece sin amenaza real o se generaliza.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Aceleración cardíaca y respiratoria.
- Tensión muscular, especialmente en piernas y abdomen.
- Sudoración, boca seca, sensación de nudo en el estómago.
- Pupilas dilatadas, hipervigilancia sensorial.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Primer paso clave: ¿la amenaza es real o percibida? Eso define la intervención.
- Si es real: acompañar la acción funcional, no eliminar el miedo.
- Si es percibida o exagerada: psicoeducación + reestructuración cognitiva.
- Exposición gradual solo cuando el miedo es desproporcionado a la amenaza.
- Técnicas de regulación fisiológica: respiración, grounding.

NOTA CLÍNICA: Clave clínica: no todo miedo es patológico. Evaluar siempre si la amenaza es real antes de intervenir sobre la emoción.

Tristeza

Respuesta ante pérdida o decepción significativa

02

FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Señala una pérdida: de persona, vínculo, proyecto, expectativa.
- Invita a la pausa, la reflexión y la reorganización interna.
- Moviliza el apoyo social y el cuidado de otros.
- Es adaptativa como parte del duelo. Desadaptativa cuando se cronifica.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Enlentecimiento general: movimientos, habla, pensamiento.
- Sensación de peso en el pecho o cuerpo.
- Llanto, falta de energía, fatiga sin causa física.
- Disminución del apetito y del interés en actividades.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Validación emocional: la tristeza tiene sentido, no hay que eliminarla.
- Activación conductual gradual para romper el ciclo de inactividad.
- Explorar la pérdida: ¿qué se perdió realmente?
- Diferenciación entre tristeza adaptativa y depresión clínica.
- Trabajo de duelo si la pérdida es significativa.

NOTA CLÍNICA: Tristeza ≠ depresión. Importante evaluar duración, intensidad e impacto funcional antes de intervenir.

Enojo

Respuesta ante injusticia, frustración o amenaza a límites

03

FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Señala una violación de límites, valores o derechos.
- Moviliza energía para la acción y la defensa.
- Puede ser una emoción secundaria que cubre miedo o tristeza.
- Adaptativa cuando impulsa al cambio. Desadaptativa cuando descontrola.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Aumento de temperatura corporal, sensación de calor.
- Tensión muscular en mandíbula, cuello y hombros.
- Aceleración cardíaca, presión en el pecho.
- Voz tensa, postura corporal de confrontación.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Pausa antes de actuar: distancia entre emoción y conducta.
- Explorar qué límite o valor fue vulnerado.
- Identificar si hay miedo o tristeza debajo de la rabia.
- Entrenamiento en asertividad: expresar la rabia sin agresión.
- Técnicas de descarga física controlada (ejercicio, movimiento).

NOTA CLÍNICA: En muchos pacientes la rabia es la emoción 'aceptada' que tapa emociones más vulnerables. Importante explorar capas.

Alegría

Respuesta ante logros, conexión y bienestar

04

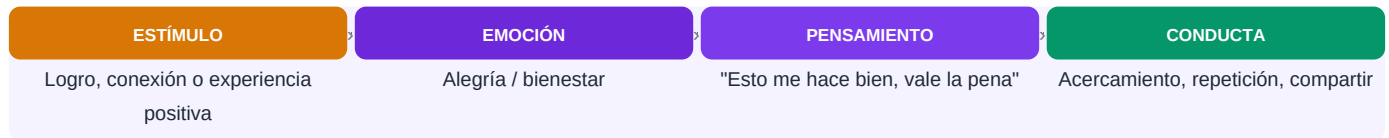
FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Refuerza conductas beneficiosas y vínculos significativos.
- Amplía el repertorio de pensamiento y acción (teoría de Fredrickson).
- Fortalece la resiliencia y los recursos psicológicos.
- Señal de que algo valioso está presente o fue logrado.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Expresión facial abierta, sonrisa genuina (músculo orbicular).
- Sensación de liviandad y energía disponible.
- Liberación de dopamina, serotonina y endorfinas.
- Relajación muscular, postura abierta y expansiva.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Trabajar la tolerancia a la alegría en pacientes con culpa o miedo al bienestar.
- Saborear: técnicas de atención plena a momentos positivos.
- Registro de emociones positivas para ampliar su reconocimiento.
- Explorar creencias que impiden disfrutar o celebrar logros.
- No minimizar ni explicar la alegría — dejar que ocurra.

NOTA CLÍNICA: Muchos pacientes tienen dificultad para sostener la alegría por creencias de que 'algo malo va a pasar'. Trabajar tolerancia al bienestar.

Asco

Rechazo ante lo percibido como contaminante o transgresivo

05

FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Protección ante sustancias, alimentos o situaciones dañinas.
- En el plano social: señala violaciones a valores morales.
- Puede extenderse hacia uno mismo (asco hacia uno mismo) en experiencias traumáticas.
- Adaptativo como protección. Problemático cuando se dirige hacia el self.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Náuseas, arcadas, tensión en el abdomen.
- Expresión facial de cierre: nariz arrugada, labio levantado.
- Distancia o alejamiento físico del estímulo.
- Puede activar el sistema parasimpático (mareos, desmayos).

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Psicoeducación: distinguir asco hacia estímulos externos vs. hacia uno mismo.
- En asco hacia uno mismo: trabajo de autocompasión y resignificación.
- Exposición gradual si hay evitación disfuncional.
- Trabajo con vergüenza asociada en casos de abuso o trauma.
- Explorar origen del asco: ¿qué valor o límite está involucrado?

NOTA CLÍNICA: El asco hacia uno mismo es frecuente en pacientes con historia de abuso o trauma. Requiere trabajo cuidadoso de autocompasión antes de exponerlos.

Culpa

Señal de transgresión a valores propios

06

FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Señala que una conducta propia violó valores o estándares personales.
- Motiva la reparación, el pedido de disculpas y el cambio.
- Adaptativa cuando impulsa a reparar. Desadaptativa cuando se vuelve crónica.
- Diferente de la vergüenza: culpa = hice algo malo / vergüenza = soy malo.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Sensación de peso o presión en el pecho.
- Rumiación mental persistente sobre el hecho.
- Dificultad para dormir o descansar.
- Tensión en el cuerpo, especialmente en hombros y cuello.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Evaluar si la culpa es proporcional a la situación real.
- Distinguir responsabilidad real de responsabilidad excesiva.
- Si hay daño real: trabajar la reparación concreta.
- Si la culpa es desproporcionada: reestructuración cognitiva.
- Diferenciar culpa funcional de culpa como patrón de personalidad.

NOTA CLÍNICA: Prestar atención a la culpa crónica sin conducta reparadora — puede enmascarar baja autoestima o creencias nucleares de ser 'malo/a'.

Vergüenza

Evaluación negativa global del self ante otros

07

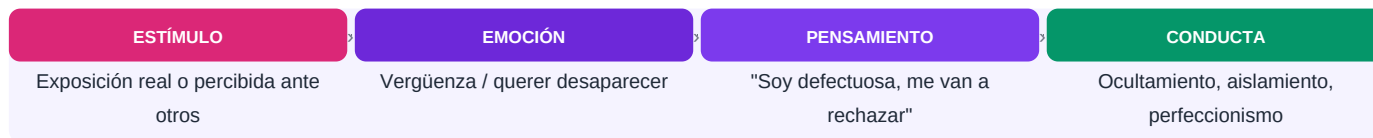
FUNCIÓN ADAPTATIVA

- Regula la conducta social y el sentido de pertenencia al grupo.
- Señala exposición percibida de aspectos considerados defectuosos.
- A diferencia de la culpa, evalúa el self completo, no solo la conducta.
- Altamente desadaptativa en formas crónicas: núcleo de muchos trastornos.

QUÉ HACE EL CUERPO

- Rubor facial, calor en la cara y cuello.
- Deseo intenso de esconderse, achicarse o desaparecer.
- Mirada hacia abajo, postura encorvada.
- Activación del sistema nervioso autónomo similar al miedo.

CICLO EMOCIONAL (EJEMPLO)



ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN

- Psicoeducación: distinguir vergüenza de culpa (conducta vs. identidad).
- Trabajo de autocompasión: la vergüenza se reduce con calor, no con crítica.
- Exposición gradual a situaciones de visibilidad social.
- Explorar origen: ¿cuándo aprendiste que eso de vos era inaceptable?
- Trabajo con creencias nucleares de defectuosidad o inamabilidad.

NOTA CLÍNICA: La vergüenza es el núcleo de muchos trastornos: TLP, depresión, adicciones, trastornos alimentarios. Abordarla requiere alianza sólida primero.